



SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA RED ASISTENCIAL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN



JEFE
GABINETE

CIRCULAR C37 N°

08

SANTIAGO,

12 JUN 2023

ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD EN PANDEMIA POR SARS-COV-2

Como es de conocimiento, este ministerio publicó un conjunto de instrucciones dirigidas a los establecimientos de la red asistencial con el propósito de implementar medidas para proteger al personal de salud y prevenir infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) causadas como consecuencia de la pandemia por SARS-CoV-2, responsable del COVID-19. Estas instrucciones han sido actualizadas en base a la mejor evidencia clínica disponible y siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud. A continuación, se indica una síntesis de estas medidas con aclaraciones y precisiones que se han estimado relevantes¹ para la situación epidemiológica actual, y son aplicables en todos los prestadores institucionales (considera dispositivos de atención de salud) de atención de salud públicos y privados del país que se encuentren en territorios en etapa de apertura. En establecimientos ubicados en territorios en otras etapas, se mantendrán las indicaciones antes vigentes.

Estrategias básicas de prevención de infecciones

En las medidas que se enuncian a continuación, se entenderá como personal de salud: "a todos los integrantes del equipo de salud, incluyendo personal clínico, personal de apoyo (incluyendo de aseo y administrativo), considerando explícitamente alumnos y profesionales que se encuentren en actividades docentes en los establecimientos de salud". Se reitera que las actividades asistenciales docentes están permitidas y no requieren de exigencias adicionales a las que se indican desde el punto de vista de prevención y control de infecciones.

1. Medidas administrativas generales:

- En los establecimientos de atención cerrada asegurar la continuidad y fortalecer a los Programas de prevención y control de IAAS de acuerdo con el Ordinario C37 n° 485 de febrero 2021² y la normativa vigente (Norma Técnica n° 225 del 26 de agosto 2022³).
- Con relación al uso de protección ocular, **se suspende la obligatoriedad de su uso permanente durante toda atención de salud directa a un paciente***. Con relación a la mascarilla (quirúrgicas, médicas o de procedimientos, o respirador de alta eficiencia si corresponde) si bien desde el punto de vista de prevención y control de IAAS, existe incertidumbre con relación a la efectividad de su uso permanente en personas asintomáticas o sin contacto con personas con cuadros respiratorios (infecciones respiratorias virales o COVID-19, entre otras), **como medida sanitaria transitoria**, se mantiene la indicación de uso obligatorio para toda persona (equipo de salud, visitas, acompañantes) durante, al menos, cualquier interacción directa y presencial con un paciente en donde ésta se genere en un espacio cerrado o no sea posible mantener

¹ De no mencionarse alguna modificación o precisión explícita con relación a las medidas antes vigentes, se entenderá que no existen cambios a implementar. **Las modificaciones o cambios con relación a la directriz anterior se señalan con *.**

² Instruye sobre prioridad de mantener las actividades del programa de prevención y control de IAAS y uso correcto de EPP durante la pandemia de Covid-19.

³ Disponible en: <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/DECRETO-N%C2%B060-DEL-26-DE-AGOSTO-2022-APRUEBA-NORMA-TECNICA-N%C2%B00225-PROGRAMA-DE-PREVENCIO%CC%81N-IAAS.pdf>

una distancia de al menos un metro. No obstante lo anterior, se deberá contar la disposición de este elemento para toda persona que lo requiera de manera voluntaria, así como según las directrices que se describen a continuación.

- c. Tal como se hace para infecciones por otros agentes endémicos o epidémicos, para la atención de pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19, mantener los procedimientos que permitan la implementación de las precauciones estándares y adicionales de contacto y gotitas requeridas, así como los procedimientos para habilitarlas (incluyendo la capacitación del personal en la aplicación de los procedimientos operativos).
- d. De acuerdo con la situación epidemiológica y de demanda asistencial, en servicios o dispositivos de urgencia se podrá habilitar flujos diferenciados para la atención de pacientes con sospecha de enfermedades respiratorias, en particular durante periodos del año con alta demanda asistencial⁴.
- e. Mantener estrategias que permitan identificar, diagnosticar y tratar de manera oportuna pacientes respiratorios, con el propósito de reducir el riesgo de exposición de otras personas consultantes, especialmente en servicios de urgencia y recintos de alta demanda.
- f. Asegurar que el personal de salud cuente con las medidas de prevención de COVID-19 (incluyendo acceso a equipo de protección personal o EPP) y cuente con capacitación actualizada en precauciones estándares y uso correcto de EPP⁵, de acuerdo con normas específicas del MINSAL en la materia^{6,7,8}.
- g. Resguardar que:
 - i. Los respiradores de alta eficiencia tipo N95 o equivalente no cuenten con válvula, y se encuentren registrados en el Registro del Instituto de Salud Pública (ISP)⁹.
 - ii. Mascarillas quirúrgicas, médicas o de procedimientos, cuenten con certificación entregada por un organismo técnico claramente identificado¹⁰ y esté con aprobación de la Dirección del establecimiento.
- h. Mantener un programa de supervisión de cumplimiento de precauciones estándares y adicionales de gotitas y contacto. En los establecimientos de atención cerrada de salud, este programa será definido y coordinado, como lo es habitualmente, por los Programas Locales de Prevención y Control de IAAS.
- i. Propender a la vacunación de todo el personal de salud de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Inmunizaciones. Conocer la cobertura local del programa de inmunizaciones del equipo de salud, identificar brechas, y crear equipos de trabajo multidisciplinarios que identifiquen posibles estrategias para corregirlas.

1.1 Medidas para el personal de salud.

- a. Educar sobre la importancia de la notificación temprana de signos, síntomas y exposición a casos de COVID-19 por parte de las Unidades de Salud Laboral o Salud del Personal.

⁴ No es una medida obligatoria, y de establecerse deberá ser autorizada por los equipos Directivos de los establecimientos, y en coordinación con los Servicios de Salud respectivos.

⁵ Los(as) estudiantes deben contar con capacitación en la materia antes de ingresar a la actividad docente en un establecimiento asistencial. Ante falencias de conocimiento que se identifiquen localmente, los establecimientos informarán a la institución formadora a la cual pertenezca dicho alumno(a), para que ella genere las instancias correctivas correspondientes.

⁶ Medidas generales descritas en: <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/01/Ord.-N%C2%BA-276-Actualizaci%C3%B3n-de-alerta-y-refuerzo-de-vigilancia-epidemiol%C3%B3gica-ante-brote-de-2019-nCoV..pdf>

⁷ Consideraciones relacionadas con el uso de EPP: <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/05/03-abr-Circular-2-Racionalizacion-uso-EPP-en-contexto-atencion-pacientes-durante-pandemia.pdf>;

⁸ <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-04-SUBSECRETARIA-DE-REDES-ASISTENCIALES.pdf>

⁹ Los respiradores de alta eficiencia son equipos de protección personal y deben estar registrados en Registro de fabricantes e importadores (RFI) del ISP <https://www.ispch.cl/listadoepp/>.

¹⁰ Por este tipo de mascarilla se entenderán: mascarilla de tres pliegues horizontales que permita ajuste universal, barra nasal maleable interior o exterior con borde pulido u otro sistema de sujeción nasal y porcentaje de eficiencia de filtración bacteriana (BFE) >= 95%. Además, debe ser conforme respecto de las siguientes normas/estándares:

- Mascarillas quirúrgicas (alta resistencia a fluidos): EN 14683 Tipo IIR; ASTM F2100 Niveles 2 a 3; YY 0469, con al menos un 95% de eficacia de filtración bacteriana (gotitas); Resistencia a fluidos a una presión mínima de 120 mmHg basada en ASTM F1862-07, ISO 22609 o equivalente U otros estándares equivalentes.
- Mascarillas de procedimiento o médicas (menor resistencia a fluidos): EN 14683 Tipo II; ASTM F2100 Niveles 1; YY/T 0969, con al menos un 95% de eficacia de filtración bacteriana (gotitas) U otros estándares equivalentes y EU MDD (Directiva) 93/42/EEC Clase I.

- b. Contar con un sistema para la detección precoz de infecciones por SARS-CoV-2 en personal de salud, el cual debe ser coordinado y liderado por los Programas de Salud Ocupacional o Salud Laboral de cada establecimiento. Se reitera que la búsqueda activa de casos en el personal de salud mediante exámenes (por lo general en contexto de brotes o sospechas de brotes) debe realizarse en coordinación con el organismo administrador de la ley respectivo.
- c. Supervisar y retroalimentar de forma inmediata, el cumplimiento de las precauciones estándares y medidas de control de infecciones de acuerdo con directrices ministeriales vigentes¹¹.
- d. Fortalecer el uso de mascarilla, protección ocular y otros elementos de protección cuando se requiera, de acuerdo con evaluación de riesgo, durante la actividad clínica asistencial, como parte de las precauciones estándares¹¹.
- e. Ante la atención directa de pacientes sospechoso o confirmados por SARS-CoV-2 u alguna otra situación de salud que amerite precauciones de gotitas, el personal de salud (clínico, administrativo y de apoyo) debe utilizar protección ocular y mascarilla quirúrgica o tipo médica de tres pliegues y, si corresponde, respirador de alta eficiencia tipo N95 o equivalente sin válvula¹².
- i. En unidades o servicios en donde se atienden pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 o infecciones por otros agentes que requieran precauciones por gotitas y en los que se realicen procedimientos generadores de aerosoles asociados con mayor riesgo de infección (PGAR), todo el personal de salud presente utilizará respiradores de alta eficiencia, a lo menos, durante la ejecución de estos procedimientos.

1.2 Medidas para los pacientes.

- a. Mantener un sistema de vigilancia activa de infecciones por SARS-CoV-2 de acuerdo con las directrices de vigilancia de IAAS publicadas vigentes^{13,14}. Identificar a pacientes con signos, síntomas o exámenes compatibles o sospechosos de infección por SARS-CoV-2 e implementar oportunamente las precauciones adicionales de contacto y gotitas.
- b. Educar sobre la importancia de avisar frente a signos y síntomas de SARS-CoV-2 y la aplicación de higiene respiratoria y etiqueta de la tos a pacientes que puedan colaborar.
- c. Mantener estrategias para identificar a pacientes sospechosos, o que han sido contacto estrecho durante su hospitalización, para evitar así que compartan habitación con otros pacientes susceptibles al interior del establecimiento o durante traslados a otros establecimientos.
- d. Se reitera que no existe desde el Programa Nacional de Prevención y Control de IAAS la indicación de mantener o realizar estrategias de búsqueda activa sistemática mediante testeo de personas asintomáticas, por ejemplo, al ingreso de una hospitalización (tamizaje de ingreso), por cuanto la evidencia de su efectividad, seguridad y sostenibilidad, se desconocen.
 - i. Si localmente el establecimiento decide mantener esta estrategia (por ejemplo, en grupos de riesgo específicos), la medida debe estar autorizada por la Dirección del establecimiento, protocolizada (considerando las acciones que se tomarán a la espera de los resultados o con los resultados ya disponibles), contar con el consentimiento del paciente y considerar que no podrá significar un retraso u obstaculizar los cuidados requeridos por el paciente.
 - ii. Adicionalmente la medida anterior, deberá ser autorizada explícitamente por la Dirección de Servicio de Salud respectivo y el valor del examen no se le podrá cobrar al paciente y será costo del establecimiento.
- e. Con relación a la solicitud de PCR u otra detección de SARS-CoV-2 antes de una cirugía o procedimiento, se reitera que, por sí sola, no constituye una condición para decidir o no su realización, y no se ha normado

¹¹ Circular C13 N° 9 de 2013 Sobre precauciones estándares para el control de infecciones en la atención de salud y algunas consideraciones sobre aislamiento de pacientes. Disponible en <https://www.minsal.cl/portal/url/item/d8615b8fdab6c48fe04001016401183d.pdf>; infografía descargable imprimible en https://www.minsal.cl/sites/default/files/files2/Infograma_Precauciones_Estandares_0.pdf

¹² <https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas-no-ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/recomendacion-uso-mascarilla-quirurgica-o-n95-en-profesionales-de-salud/>

¹³ <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/Manual-Definiciones-y-criterios-de-IAAS-An%CC%83o-2023.pdf>

¹⁴ Circular C37 N° 6 de 2023. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud – IAAS. Disponible en <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/Manual-vigilancia-de-IAAS-segunda-version-2023.pdf>

su indicación como requisito previo a procedimientos quirúrgicos mayores ni menores, endoscópicos, partos u otros procedimientos invasivos. Se reitera que la ejecución o postergación de estos procedimientos deben obedecer a evaluaciones riesgo/beneficio individualizadas, y en ningún caso su implementación podrá significar un retraso general de los cuidados requeridos por los pacientes, tal como se ha mencionado.

1.3 Medidas para las visitas y acompañantes

- a. Las visitas y acompañantes son permitidos. Durante el acceso de visitas, implementar medidas que permitan identificar signos y síntomas y exposición de SARS-CoV-2; así como la educación de higiene de manos, distanciamiento físico y etiqueta de la tos, incluyendo la disponibilidad y acceso oportuno a entrega de mascarillas, de requerirse.
- b. Resguardar que aquellos pacientes que requieren acompañamiento de familiares o personas significativas se evalúen y respeten las necesidades y bienestar del paciente. Respetar los lineamientos Ministeriales vigentes al respecto¹⁵.

2.- Medidas ambientales y de ingeniería

- a. Resguardar que la distancia entre pacientes sea al menos de un metro (considerar la distancia entre los límites más próximos de las cabeceras de las camas/camillas de los pacientes) tanto en hospitalizados como en procedimientos ambulatorios
- b. Propender que las salas dispongan de ventilación, ya sea con métodos naturales, mecánicos o mixtos¹⁶.
 - i. Para sectores en los cuales se realice atención de pacientes sin ejecución de procedimientos generadores de aerosoles asociados con mayor riesgo de infección (PGAR) (anexo 1): 60 litros/segundo/paciente si es ventilación natural o 6 recambios de aire por hora (equivalente a 40 litros/segundo/paciente) si es ventilación mecánica o mixta.
 - ii. Para sectores en los cuales se realice atención de pacientes con ejecución de PGAR: contar con al menos 6 recambios de aire por hora, o idealmente de 12 recambios de aire por hora si se cuenta con sistemas mecánicos de ventilación, o tasas de ventilación mínima media por hora de 160 litros/segundo/paciente, con un mínimo de 80 litros/segundo/paciente, de contarse con sistemas de ventilación natural.
 - (i) Las habitaciones con sistemas de manejo de aire donde éste recircule hacia otras habitaciones o espacios con otros pacientes deben contar con filtros de alta eficiencia (HEPA) que filtren el aire antes de recircular.
- c. En los recintos en donde se realice actividad clínica asistencial, el número de personas presentes debe ser el mínimo necesario para cumplir con este objetivo, por lo que no se puede indicar un aforo predeterminado.
- d. Mayor referencia con relación a condiciones estructurales para la implementación de precauciones adicionales (aislamientos), seguir orientaciones entregadas en circular C37 n° 07 de junio 2018¹⁷ y Ord. B51 n° 276 de enero 2020¹⁸.
- e. En el caso de uso aire acondicionado considerar¹⁹:
 - i. Toma de aire del exterior (de preferencia)
 - ii. Salida del aire al exterior no hacia otras áreas del hospital o del establecimiento, en particular espacios cerrados.
 - iii. Que no exista recirculación entre salas distintas.
 - iv. Ubicación del sistema, evitar que el flujo aire se dirija directo hacia las personas.

¹⁵ Como mínimo, considerar las relacionadas con Ley 20.584 y sus modificaciones, ley Mila y Ley Dominga y sus respectivas normativas.

¹⁶ World Health Organization. Severe acute respiratory infections treatment centre: Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities. 2020 <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331603>

¹⁷ Reitera instrucciones sobre aislamiento de pacientes para prevención de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS).

¹⁸ Actualización de alerta y refuerzo de vigilancia epidemiológica ante brote de 2019-nCoV. <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/01/Ord.-N%C2%BA-276-Actualizaci%C3%B3n-de-alerta-y-refuerzo-de-vigilancia-epidemiol%C3%B3gica-ante-brote-de-2019-nCoV..pdf>

¹⁹ El rol del aire acondicionado en la transmisión de SARS-CoV-2 no se ha identificado, por lo que las siguientes son una síntesis de las principales recomendaciones de organismos y agencias nacionales e internacionales.

- v. Si el sistema funciona con recirculación de aire debe contar con filtro.
- vi. Contar con mantención del sistema incluyendo limpieza de ductos.
- vii. Verificar que el sistema funcione independiente de la humedad o temperatura para mantener las condiciones de ventilación sin modificaciones.
- viii. Identificar dentro de la institución al responsable del manejo y supervisión de los programas de mantención preventiva de los equipos de aire acondicionado y revisión cambio de filtros, de ser pertinente.

3.- Medidas individuales

3.1 Precauciones estándares

- a. Como principio general, durante la atención de todo paciente se aplicarán las precauciones estándares que incluyen²⁰:
 - i. Higiene de manos: Puede ser realizada con agua y jabón (40-60 segundos) o solución en base alcohólica (20-30 segundos) si las manos están visiblemente limpias.
 - ii. Uso de EPP de acuerdo con evaluación de riesgo.
 - iii. Higiene respiratoria y etiqueta de la tos.
 - iv. Limpieza y desinfección: se deben seguir las orientaciones generales entregadas en la circular C37 n°06 de octubre 2021²¹.
 - v. Manejo de residuos que deben seguir las orientaciones del REAS. **Se suspende la indicación de ordinario B32 n°1040 de abril 2020 de manejar todo EPP usado en casos sospechosos o confirmados de COVID-19 como residuo especial*.**
 - (i) Todos los residuos generados durante la atención de pacientes confirmados con COVID-19 se eliminarán como residuos asimilables a domiciliarios cumpliendo las orientaciones del REAS.
 - (ii) No se requiere manejo con doble bolsa o la aplicación de algún desinfectante para su manipulación.
 - (iii) Todos los residuos como mascarillas que se generen en áreas administrativas, de apoyo o áreas de atención no COVID se eliminarán como residuos asimilables a domiciliario o de acuerdo con lo instruido en el REAS.

3.2 Precauciones adicionales de contacto y gotitas

- a. La implementación de precauciones adicionales se realizará durante la atención de pacientes en los que se sospeche o exista confirmación de una infección por un microorganismo en el cual las precauciones estándares no sean suficientes²².
- b. En pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19, se sumarán a las precauciones estándares las precauciones adicionales de contacto y gotitas. Estas incluyen: higiene de manos, uso delantal y guantes, protección ocular (escudo facial o antiparras) y mascarilla quirúrgica, médica o de procedimiento. En caso de PGAR, todo el equipo de salud presente reemplazará la mascarilla quirúrgica, médica o de procedimiento por respirador de alta eficiencia sin válvula tipo N95 o equivalente^{23,24}.

²⁰ Circular C13 N° 9 de 2013 Sobre precauciones estándares para el control de infecciones en la atención de salud y algunas consideraciones sobre aislamiento de pacientes. Disponible en <https://www.minsal.cl/portal/url/item/d8615b8fdb6c48fe04001016401183d.pdf>; infografía descargable imprimible en https://www.minsal.cl/sites/default/files/files2/Infograma_Precauciones_Estandares_0.pdf

²¹ <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/01/0006-CIRCULAR-RECOMENDACIONES-SOBRE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCION-DE-SUPERFICIES.pdf>

²² <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/05/03-abr-Circular-2-Racionalizacion-uso-EPP-en-contexto-atencion-pacientes-durante-pandemia.pdf>

²³ Ordinario B51 n° 276 de 2020. <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/01/Ord.-N%C2%BA-276-Actualizaci%C3%B3n-de-alerta-y-refuerzo-de-vigilancia-epidemiol%C3%B3gica-ante-brote-de-2019-nCoV..pdf>

²⁴ Recordar consideraciones de uso de respirador de alta eficiencia. <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-USO-DE-EQUIPOS-DE-PROTECCI%C3%93N-PERSONAL-EN-LA-PREVENCI%C3%93N-DE-TRANSMISI%C3%93N-COVID19-versi%C3%B3n-24-03-2020-corregido-%C3%BAltima-p%C3%A1gina.pdf>

- c. Se debe preferir el manejo de estos pacientes en salas o habitación individual, pero pacientes con igual agente pueden compartir habitación de no existir infección o colonización concomitante por otro microorganismo que requiere de precauciones adicionales de contacto.
- d. La duración de las precauciones adicionales basadas en mecanismos de transmisión²⁵ será de 5 días desde la fecha del inicio de síntomas (o de toma de PCR en asintomáticos), cumpliéndose al menos 1 día sin fiebre sin uso de antipiréticos y con presencia de mejoría clínica (no ausencia) de los síntomas (disnea, tos, requerimientos de oxígeno).
 - i. En pacientes con cuadros graves de COVID-19 (neumonía con requerimiento de hospitalización), no inmunocomprometidos, la duración de las precauciones adicionales basadas en mecanismos de transmisión será de 10 días desde la fecha del inicio de síntomas (o de toma de PCR en asintomáticos), cumpliéndose al menos 1 día sin fiebre sin uso de antipiréticos y con presencia de mejoría clínica (no ausencia) de los síntomas (disnea, tos, requerimientos de oxígeno).
 - ii. En pacientes con inmunocompromiso²⁶, la duración de las precauciones adicionales basadas en mecanismos de transmisión será de 20 días desde el inicio de síntomas (o de toma de PCR en asintomáticos), cumpliéndose al menos 1 día sin fiebre sin uso de antipiréticos y con presencia de mejoría clínica (no ausencia) de los síntomas (disnea, tos, requerimientos de oxígeno).

4.- Manejo y Estudio de Brotes por SARS-CoV-2

- a. Continúan vigentes las instrucciones entregadas en la circular C37 n°09 de septiembre de 2022²⁷.

5.- Definición de exposición en establecimientos de atención de salud

- a. Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia del paciente confirmado para SARS-CoV-2 durante al menos 15 minutos; o independiente de la distancia con el paciente y tiempo de exposición, el contacto ocurre al encontrarse en una misma habitación durante la ejecución de procedimientos generadores de aerosoles con mayor riesgo de infección (PGAR).

²⁵ Sin cambios con relación a directriz anterior. No se recomienda como medida rutinaria la toma de PCR como criterio o medida de seguimiento para definir el momento de finalizar las precauciones adicionales en pacientes con diagnóstico de COVID-19.

²⁶ Personas que han recibido trasplante, que recibe un tratamiento prolongado con corticoides u otro medicamento inmunomodulador o quimioterapia para el cáncer, personas que viven con VIH y con recuento de CD4 bajo 200 cel/mm³ o sin terapia antirretroviral, con una inmunodeficiencia o cualquier otro cuadro en el cual el equipo tratante determine que existe un compromiso importante de la respuesta inmune del organismo.

²⁷ Disponible en <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/09-CIRCULAR-DEL-30-DE-SEPT.-ACTUALIZACION-DE-LAS-MEDIDAS-DE-PREVENCIÓN-Y-CONTROL-DE-INFECCIONES-CONTEXTO-PANDEMIA.pdf>

- b. En procedimientos o actividades que no son PGAR en un paciente confirmado para SARS-CoV-2, la actividad se realiza sin uso de protección ocular (escudo facial o antiparras) y mascarilla quirúrgica, médica o de procedimiento; mientras que durante procedimientos o actividades PGAR, la actividad se realiza sin protección ocular o respirador tipo N95 o equivalente.
- c. Para actividades que no se traten de atención clínica, se deben consultar normativas vigentes al respecto.

Las indicaciones entregadas se encuentran en constante revisión y sujetas a modificaciones de acuerdo con la situación epidemiológica y evidencia disponible.

Saludan atentamente a Usted,



DR. FERNANDO ARAOS DATTOLI
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES



ANDREA ALBAGLI IRURETAGOYENA
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

Distribución

Directores Servicios de Salud del País
Subsecretaría de Salud Pública
Subsecretaría de Redes Asistenciales
Superintendencia de Salud
SEREMIs de Salud
División de Gestión de la Red Asistencial DIGERA
División de Atención Primaria DIVAP
División de Políticas Públicas DIPOL
División de Gestión y Desarrollo de las Personas DIGEDEP
División de Prevención y Control de Enfermedades DIPRECE
Departamento de Seguridad y Calidad de la Atención
Oficina de Partes